

PROTOCOLO ASISTENCIAL

MANEJO DEL PACIENTE POLICONTUSIONADO EN BOX DE OBSERVACIÓN DE URGENCIAS

1. OBJETO

Establecer un procedimiento normalizado para la atención, monitorización, tratamiento y seguimiento de pacientes policontusionados que requieran permanencia temporal en el Área de Observación del Servicio de Urgencias.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Aplicable a pacientes adultos atendidos en el Servicio de Urgencias de un hospital comarcal tras sufrir traumatismos cerrados con múltiples contusiones y sin criterios iniciales de activación de Código Trauma Grave.

3. DEFINICIONES

Paciente policontusionado

Paciente que presenta dos o más lesiones contusas en diferentes regiones anatómicas, secundarias a traumatismo cerrado, con estabilidad hemodinámica y sin lesiones vitales evidentes en la valoración inicial.

Observación de Urgencias

Área asistencial destinada a vigilancia clínica, monitorización, tratamiento y reevaluación periódica durante un periodo generalmente inferior a 24 horas.

4. OBJETIVOS

Objetivo general

Garantizar una atención segura, homogénea y eficiente de los pacientes policontusionados.

Objetivos específicos

- Detectar precozmente lesiones ocultas.
- Tratar adecuadamente dolor y síntomas asociados.
- Identificar deterioro clínico.
- Evitar ingresos innecesarios.
- Garantizar una correcta continuidad asistencial.

5. CRITERIOS DE INCLUSIÓN

Ingresarán en Observación pacientes que presenten:

Adultos

- Politraumatismo leve o moderado estable. Hablamos de pacientes con los siguientes mecanismos de lesión que tienen pruebas complementarias normales (TAC BODY sin lesiones a ningún nivel):

- ⑩ Caída de adultos >6m (un balcón son 3 m), pediátricos >3m o dos veces la altura del niño.
- ⑩ Vuelcos.
- ⑩ Atropellos de peatón.
- ⑩ Intrusión del vehículo (deformidad del mismo hacia dentro) >35-40 cm.
- ⑩ Muerte de uno de los ocupantes del vehículo
- ⑩ Accidente de motocicleta > 30km/h.
- ⑩ Accidente de coche >100km/h.
- ⑩ Tiempo de extracción prolongado.

⑩ Expulsión del paciente fuera del vehículo.

- Pacientes no fiables considerados: bajo efectos de las drogas o alcohol, con reacción aguda al estrés.

- Dolor de difícil control inicial.
- Necesidad de observación clínica evolutiva.
- Sospecha de lesión no objetivable inicialmente.
- Traumatismo craneoencefálico leve con criterios de vigilancia.
- Traumatismo torácico leve estable.
- Contusión abdominal estable con pruebas iniciales negativas.
- Pacientes anticoagulados tras traumatismo.
- Ancianos frágiles con riesgo de complicaciones.

⑩ Expulsión del paciente fuera del vehículo.

- Pacientes no fiables considerados: bajo efectos de las drogas o alcohol, con reacción aguda al estrés.

- Dolor de difícil control inicial.
- Necesidad de observación clínica evolutiva.
- Sospecha de lesión no objetivable inicialmente.
- Traumatismo craneoencefálico leve con criterios de vigilancia.
- Traumatismo torácico leve estable.
- Contusión abdominal estable con pruebas iniciales negativas.
- Pacientes anticoagulados tras traumatismo.
- Ancianos frágiles con riesgo de complicaciones.

6. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

Ingreso directo

- Inestabilidad hemodinámica.
- Glasgow <13.
- Hemorragia activa.
- Fracturas inestables.
- Lesiones viscerales confirmadas.
- Necesidad de cirugía urgente.

- Insuficiencia respiratoria aguda.
- Trauma grave activado.

Alta directa

- Lesiones leves sin criterios de observación.
- Dolor controlado.
- Exploración normal.
- Pruebas complementarias sin hallazgos relevantes.

7. RECURSOS NECESARIOS

Recursos humanos

- Médico de Urgencias.
- Enfermería de Observación.
- TCAE.
- Celador.
- Consultores de especialidades.

Recursos materiales

- Monitor multiparamétrico.
- Pulsioximetría.
- Material para canalización venosa.
- Carro de parada.
- Ecógrafo.
- Sistemas de inmovilización.
- Analgesia y fluidoterapia.

8. ESCALAS RECOMENDADAS (Anexos)

Adultos

- EVA dolor.
- Glasgow.
- NEWS2.
- Índice de Shock.

9. PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Según sospecha clínica:

Laboratorio

- Hemograma.
- Bioquímica.
- Coagulación.
- Grupo y reserva.

Radiología

- Rx tórax.
- Rx pelvis.
- Rx extremidades.

TAC

- Cráneo-cérvico-toraco-abdominal.

ECOGRAFÍA FAST/E-FAST O DIRIGIDA.

10. TRATAMIENTO

Analgesia escalonada

- Dolor leve - moderado

Paracetamol / Metamizol

- Dolor intenso

Opioides titulados IV.

- Dolor muy intenso

Morfina IV.

Medidas generales

- Reposo.
- Elevación extremidades.
- Inmovilización cuando proceda.

Fluidoterapia

Indicada según estado clínico.

Profilaxis

Según valoración individual:

- Antitetánica.
- Antitrombótica.

11. CUIDADOS DE ENFERMERÍA

Monitorización

- TA.
- FC.
- FR.
- SatO₂.
- Temperatura.

Registro del dolor

Ingreso. Cada reevaluación. Previo al alta.

Vigilancia

- Neurológica.
- Respiratoria.
- Hemodinámica.

Cuidados generales

- Movilización segura.
- Prevención de úlceras.
- Higiene.
- Educación sanitaria.

12. REEVALUACIÓN CLÍNICA

Frecuencia mínima

Primeras 2 horas: Cada 30-60 minutos. Posteriormente:

Cada 2-4 horas.

Reevaluar

- Dolor.
- Glasgow.
- Constantes vitales.
- Exploración física.
- Resultados pendientes.

13. CRITERIOS DE ALTA

Todos los siguientes:

- Estabilidad hemodinámica.
- Dolor controlado.
- Exploración sin cambios.
- Pruebas complementarias negativas o sin relevancia.
- Tolerancia oral.
- Deambulación adecuada.
- Apoyo domiciliario.

Instrucciones al alta

Signos de alarma. Tratamiento domiciliario. Control por Atención Primaria.

14. CRITERIOS DE INGRESO HOSPITALARIO

- Deterioro clínico.
- Hallazgos radiológicos relevantes.
- Dolor intratable.
- Complicaciones respiratorias.
- Alteraciones neurológicas.
- Riesgo social importante.

15. CRITERIOS DE DERIVACIÓN A ESPECIALIDADES

Traumatología

Fracturas. Luxaciones. Lesiones ligamentarias.

Cirugía General

Trauma abdominal. Lesiones viscerales.

Neurocirugía

TCE con hallazgos intracraneales.

Medicina Interna

Comorbilidad compleja.

Hospitalización a domicilio

Pacientes frágiles con poco o nulo apoyo familiar / social para valorar evolución y/o control del dolor

16. INDICADORES DE CALIDAD

- Tiempo hasta analgesia <30 min.
- Registro completo X-ABCDE >95%.
- Reevaluaciones documentadas >90%.
- Reconsultas <72 horas.
- Ingresos tras alta desde observación.
- Eventos adversos relacionados con el proceso.

17. RESPONSABILIDADES

Médico responsable: Valoración, tratamiento y decisión final.

Enfermería: Monitorización, cuidados y registros.

Supervisor de Urgencias: Seguimiento de indicadores.

18. BIBLIOGRAFÍA

- SEMES. Manual de Procedimientos en Urgencias.
- ATLS (Advanced Trauma Life Support).
- Guías NICE Trauma.
- European Trauma Guidelines.
- Ministerio de Sanidad. Estrategia de Seguridad del Paciente.

ANEXOS

1. Escala EVA del dolor



2. Escala Glasgow

Escala de Coma de Glasgow

	 Ocular	 Verbal	 Motora
1	Ausente	Ausente	Ausente
2	Dolor	Incomprensible	Extensión anormal (descerebración)
3	Verbal	Inapropiada	Flexión anormal (decorticación)
4	Espontánea	Confuso	Retira ante dolor
5		Orientado	Localiza dolor
6			Sigue instrucción

Mínimo: 3 puntos
Máximo: 15 puntos
Las diferentes categorías pueden ser no evaluables.

3. Escala NEWS 2

Nombre:		Fecha:	
			Valor***
A+B	Frecuencia Respiratoria (Respiraciones/min)	≥ 25	3
		21-24	2
		12-20	0
		9-11	1
		≤ 8	3
	Saturación O ₂ (Escala 1) (%)	≥ 96	0
		94-95	1
		92-93	2
		≤ 91	3
	Saturación O ₂ (Escala 2) (%) Pacientes EPOC Con SpO ₂ Rango 88%-92%	≥ 97 con O ₂	3
		95-96 con O ₂	2
		93-94 con O ₂	1
≥ 93 sin O ₂		0	
88-92 con O ₂		0	
86-87 con O ₂		1	
84-85 con O ₂		2	
≤ 83 con O ₂	3		
¿Aporte de oxígeno?	NO	0	
	SÍ	2	
Dispositivo*			
C	Presión arterial sistólica (mmHg)	≥ 220	3
		111-219	0
		101-110	1
		91-100	2
		≤ 50-90	3
	Frecuencia cardíaca (Latidos/min)	≥ 131	3
		111-130	2
		91-110	1
	51-90	0	
	41-50	1	
	≤ 30-40	3	
	D	Nivel de consciencia	Alerta
Confusión**			3
Verbal			3
Dolor			3
Sin respuesta			3
E	Temperatura (°C)	≥ 39,1	2
		38,1-39,0	1
		36,1-38,0	0
		35,1-36,0	1
		≤ 35,0	3
Puntuación final			

*Registrar tipo de dispositivo de aporte de oxigenoterapia (Ej.: gafas nasales, reservorio...).

**Seleccionar confusión, solo cuando esta sea de nueva aparición.

*** Valor de puntuación otorgado a cada constante vital.

Figura 1. Segunda versión de la escala de alerta temprana NEWS-2.

4. Índice de Shock

ÍNDICE DE CHOQUE		
FRECUENCIA CARDIACA PRESIÓN ARTERIAL SISTÓLICA		
VALORES REFERENCIALES		
NORMAL	0.5 - 0.7	
CHOQUE	0.8 O +	
CONDICIÓN	VALOR	INTERPRETACIÓN
TRAUMA	0.8 O MÁS	PREDICTOR DE TRANSFUSIÓN MASIVA
TRAUMA	1 O MÁS	PREDICTOR DE MORTALIDAD
SEPSIS	MAYOR A 1	POBRE VALOR PREDICTIVO POSITIVO DE HIPERLACTEMIA / MORTALIDAD

CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN EL PACIENTE CON:

POLICONTUSIONADO LEVE.

El paciente policontusionado puede tener afectación en distintas partes del cuerpo dependiendo del origen de su accidente, por lo que debemos vigilar los siguientes aspectos:

Signos y síntomas a vigilar

- **Constantes vitales**
- **Estado de la vía aérea**
 - ♣ **Permeable**
- **Estado respiratorio:**
 - ♣ **Frecuencia respiratoria** (taquipnea es signo de gravedad).
 - ♣ **Disnea** o aumento del trabajo respiratorio.
 - ♣ **Uso de músculos accesorios** y tiraje.
 - ♣ **Saturación de oxígeno (SpO₂)** y necesidad creciente de oxígeno.
 - ♣ **Cianosis** en labios o dedos.
 - ♣ **Tipo de respiración:** superficial, irregular o fatigada.
- **Estado hemodinámico:**
 - ♣ Taquicardia
 - ♣ Hipotensión
 - ♣ Palidez
 - ♣ Mareo o debilidad, signos de sangrado
- **Dolor:**
 - ♣ Localización, intensidad, irradiación
 - ♣ Inicio, duración, patrón (cólico, continuo...)
 - ♣ Respuesta a la analgesia.
- **Estado neurológico**, con especial relevancia en cambios respecto al previo.
 - ♣ Valoración del estado de COC
 - ♣ Escala ADVN.
- **Aparición de focalidad neurológica:**
 - ♣ Afasia/disfasia
 - ♣ Pérdida de fuerza en extremidades
 - ♣ Agitación. Crisis epilépticas o crisis focales.
 - ♣ cefalea intensa

- ♣ náuseas o vómitos
- ♣ visión borrosa
- ♣ mareo.
- **Posibles fracturas:**
 - ♣ Aparición de hematomas o edemas en la piel
 - ♣ Deformidades o crepitación

Signos de alarma

- Dificultad respiratoria.
- Dolor abdominal intenso.
- Alteración conciencia.
- Sangrado activo

BIBLIOGRAFÍA:

1. - Ferrer Tarrés JM, Prat Marín A, Tomás Vecina S. Revisión de la utilización de las áreas de observación de urgencias hospitalarias. Med Clin (Barc). 2007;128(6):224-31. Quirónsalud.
2. - Inhaladores de cartucho presurizado: técnica de inhalación. Escuela de Pacientes Neumología. Madrid: Quirónsalud; 2023. Disponible en: <https://www.quironsalud.com> [Acceso 04 sept 2026]. Servicio Andaluz de Salud.
3. - Guía de diseño y organización de servicios de urgencias hospitalarias. Sevilla: Consejería de Salud; 2016. Soler Gómez Y, Fernández Viñado DM, Martínez Fernández C, et al.
4. - Atención de enfermería al paciente politraumatizado por accidente de tráfico: enfoque integral en la emergencia. Rev Sanitaria Invest. 2025;6(7):e2660-7085. Sánchez Reyes E, Pinal Moreno E, Ortega Vargas MC.
5. - Guía clínica de enfermería del enfermo con insuficiencia cardíaca. Rev Enferm IMSS. 2004;12(3):155-62. Grupo de Trabajo de EPOC SEMERGEN.
6. - Protocolo de manejo del paciente con EPOC agudizado en urgencias. SEMERGEN. 2020;46(Supl

- 1):1-12. Gómez Martínez A, González Vallejo ML, García Cuesta P.
7. - Plan de cuidados enfermeros en el paciente con EPOC y neumonía según taxonomía NANDA-NIC-NOC. Rev Enferm CyL. 2018;10(2):45-58. Gobierno de Canarias.
 8. - Guía de atención a emergencias sanitarias en los centros educativos: Traumatismos II. Las Palmas: Consejería de Educación; 2021.Universidad de Salamanca.
 9. - Guía docente Enfermería en Urgencia y Riesgo Vital. Grado en Enfermería. Ávila: USAL; 2024-2025.Mayo Clinic.
 10. - Inhaladores para el asma: ¿cuál es el indicado para usted? Rochester: Mayo Foundation; 2024. Disponible en: <https://www.mayoclinic.org> [Acceso 04 sept 2026].
 11. - Guía de actuación en urgencias de la Sociedad Española de Enfermería de Urgencias y Emergencias (SEEUE)
 12. - Cuidados de enfermería en el paciente crítico en urgencias de García González, M., et al. (2020)
 13. - Manejo del paciente con dolor torácico en urgencias de López López, J., et al. (2019)
 14. - Emergencias (revista de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias)
 15. - Enfermería de Urgencias (revista especializada en cuidados de enfermería en urgencias)
 16. - SEMES (Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias) - Guías y protocolos
 - 17.- SEEUE (Sociedad Española de Enfermería de Urgencias y Emergencias) - Recursos y documentos